

### 1. Introducción y relevancia clínica

Las **infestaciones parasitarias de la piel** son patologías comunes, especialmente en contextos de **hacinamiento, pobreza, y falta de higiene**, pero también pueden observarse en cualquier nivel socioeconómico.

En Chile, los casos de **escabiosis** (sarna) han aumentado periódicamente, constituyendo **brotes comunitarios y hospitalarios**.

La **pediculosis**, por su parte, es una de las causas más frecuentes de prurito en niños en edad escolar.

Aunque **no son enfermedades graves**, su **alto contagio y repercusión social** las hace clínicamente relevantes. El reconocimiento rápido, tratamiento correcto y manejo de los contactos son claves para prevenir recurrencias y epidemias.

---

### 2. Fisiopatología y bases conceptuales

#### 2.1. Escabiosis (sarna humana)

- Agente etiológico: *Sarcoptes scabiei* var. *hominis*, ácaro microscópico de 0.4 mm.
- Vive y se reproduce en el **estrato córneo** de la piel humana.
- Transmisión: contacto **piel a piel prolongado** (relaciones sexuales, convivencia) o fómites (ropa, sábanas).
- Cada hembra excava **túneles subcutáneos** donde deposita huevos y heces → reacción alérgica local → **prurito intenso**.

#### 2.2. Pediculosis (piojos)

- Infección por **insectos ectoparásitos hematófagos** obligados.
- Especies humanas:
  - *Pediculus humanus capitis* (cabeza).
  - *Pediculus humanus corporis* (cuerpo).

- *Pthirus pubis* (pubis).
  - Se alimentan de sangre y depositan **liendres (huevos)** adheridas al pelo o ropa.
  - Transmisión: contacto directo o por objetos personales.
- 

## 3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

---

### 3.1. Escabiosis (Sarna)

#### Síntomas

- **Prurito intenso nocturno**, especialmente al acostarse (reacción alérgica al ácaro y sus productos).
- Afecta a varios miembros de la familia o contactos.
- El prurito puede persistir semanas después del tratamiento.

#### Lesiones características

- **Túneles o surcos acarinos**: líneas finas, grises, serpiginosas, con vesícula o pápula terminal (sitio de hembra).
- **Pápulas eritematosas y excoriaciones** por rascado.
- **Costras hemáticas o impetiginización secundaria**.
- **Localización típica**:
  - Espacios interdigitales, muñecas, axilas, areolas, ombligo, genitales, glúteos, abdomen bajo.
  - En lactantes: puede afectar **palmas, plantas y cuero cabelludo** (zonas atípicas en adultos).

#### Formas especiales

1. **Sarna noruega o costrosa**:
  - En inmunodeprimidos, ancianos o personas con discapacidad.

- Cientos de ácaros → lesiones hiperqueratósicas gruesas, generalizadas, con alta contagiosidad.
- Prurito leve o ausente.

## 2. Sarna nodular:

- Pápulas o nódulos eritematosos residuales, persistentes, especialmente en escroto y axilas.

---

## Diagnóstico diferencial de escabiosis

| Patología            | Diferencias clave                                |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Dermatitis atópica   | Historia crónica, sin contagio, en flexuras      |
| Urticaria            | Lesiones fugaces, no persistentes                |
| Prurito del embarazo | Localización abdominal, sin surcos               |
| Pediculosis          | Liendres visibles en el cabello, sin surcos      |
| Prurigo              | Lesiones papulares aisladas, sin patrón familiar |

---

## 3.2. Pediculosis

### A. Pediculosis capitis (cabeza)

- Más frecuente en **niños escolares**, contagio por contacto directo o peines.
- **Prurito intenso del cuero cabelludo**, especialmente en región occipital y retroauricular.

- Hallazgos:
  - **Liendres:** pequeñas estructuras ovaladas blanquecinas firmemente adheridas al tallo piloso, a pocos milímetros del cuero cabelludo.
  - **Piojos adultos:** móviles, difíciles de ver.
  - **Excoriaciones, costras y adenopatías cervicales** por rascado.

## B. Pediculosis corporis

- Infección por *P. humanus corporis*.
- Piojos viven en costuras de la ropa, no en la piel.
- Lesiones: excoriaciones, pápulas hemorrágicas en tronco y cintura.
- Asociada a **hacinamiento y mala higiene**.

## C. Pediculosis pubis (ladillas)

- Causada por *Pthirus pubis*.
- Transmisión **sexual**.
- Lesiones: pápulas pruriginosas, excoriaciones, presencia de **puntitos azulados (maculae cerúleae)** por hemoglobina degradada.
- Puede afectar axilas, cejas o pestañas (niños).

---

## Diagnóstico diferencial de pediculosis

| Patología             | Diferencias clave                            |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Dermatitis seborreica | Escamas amarillentas, sin liendres adheridas |
| Caspa                 | Desprendimiento fácil, sin prurito intenso   |

Escabiosis                      Surcos, distribución interdigital o genital

Foliculitis                      Pústulas centradas en folículos

---

## 4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

| Examen                                              | Utilidad                 | Hallazgo característico                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Observación directa / lupa dermatológica            | Diagnóstico de elección  | Identificación de ácaro, liendres o piojos vivos         |
| Raspado con bisturí y examen con KOH o tinta Parker | Escabiosis               | Visualización del ácaro, huevos o heces                  |
| Dermatoscopía (epiluminiscencia)                    | Rápido y no invasivo     | Imagen del ácaro (“delta wing jet sign”)                 |
| Biopsia cutánea (rara vez necesaria)                | Sarna costrosa o atípica | Hiperqueratosis con parásitos visibles en estrato córneo |

El diagnóstico de ambas infestaciones es **principalmente clínico y visual**.

---

## 5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

---

### 5.1. Escabiosis

Tratamiento de elección

Permetrina 5% crema tópica

- Aplicar **desde el cuello hacia abajo** (incluyendo uñas, pliegues, genitales y plantas en lactantes).
- En lactantes <2 meses, aplicar también en cuero cabelludo.
- Dejar **8–12 h** y enjuagar.
- **Repetir a los 7 días.**

### Alternativas

- **Azufre precipitado 6–10%** (en neonatos o embarazadas).
- **Ivermectina oral** 200 µg/kg (dosis única, repetir a los 7–14 días)
  - Indicada en brotes institucionales o sarna costrosa.
  - Contraindicada en <15 kg o embarazadas.

### Medidas complementarias

- **Tratar simultáneamente a todos los convivientes** (aunque asintomáticos).
- Lavar ropa, sábanas y toallas a >60°C o sellar en bolsa 72 h.
- Cortar uñas y limpiar debajo.
- Antihistamínicos para prurito.
- Tratar impetiginización con antibióticos tópicos o sistémicos.

## 5.2. Pediculosis

### Tratamiento de elección

#### Permetrina 1% loción o shampoo

- Aplicar sobre cabello seco, dejar actuar 10 minutos y enjuagar.
- Peinar con peine fino para eliminar liendres.
- Repetir a los **7–10 días** para erradicar ninfas eclosionadas.

## Alternativas

- **Dimeticona 4% (loción o spray)** → alternativa no insecticida, segura en niños.
- **Ivermectina oral 200 µg/kg dosis única** (repetir a los 7 días si infestación persistente).
- En pediculosis pubis: permetrina 1% tópica o ivermectina oral; tratar contactos sexuales.

## Medidas adicionales

- Lavar ropa, peinetas y gorros con agua caliente (>50°C).
- Revisar y tratar convivientes o parejas.
- No usar tratamientos profilácticos sin diagnóstico.

---

## 6. Complicaciones y pronóstico

| Patología            | Complicaciones                                                                  | Pronóstico                                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Escabiosis           | Sobreinfección bacteriana (impétigo), eczema post-sarna, dermatitis de contacto | Excelente con tratamiento correcto        |
| Sarna costrosa       | Sepsis en inmunodeprimidos, contagio masivo                                     | Requiere manejo hospitalario              |
| Pediculosis          | Dermatitis irritativa, piodermitis, adenopatías cervicales                      | Excelente con higiene y control ambiental |
| Pediculosis corporal | Transmisión de enfermedades (tifus, fiebre recurrente)                          | Prevención con aseo y cambio de ropa      |

---

## 7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



## Perlas clínicas

1. **Prurito nocturno familiar + surcos interdigitales** → **escabiosis** (diagnóstico EUNACOM clásico).
  2. En **sarna costrosa**, hay **miles de ácaros**, pero **prurito leve o ausente**.
  3. **Permetrina 5%** es el tratamiento de elección en todas las edades (excepto <2 meses).
  4. Si persiste prurito post-tratamiento, **no es fracaso terapéutico**, sino reacción inflamatoria residual.
  5. **Pediculosis capitis**: diagnóstico por **liendres adheridas firmemente al cabello**, no por caspa.
  6. En pediculosis pubis, buscar y tratar **otras ITS** y **contactos sexuales**.
  7. En brotes de escabiosis institucional, usar **ivermectina oral masiva**.
- 



## Errores comunes

- Tratar solo al paciente y no a los convivientes → reinfestación.
  - Aplicar permetrina **solo en áreas pruriginosas**, no en todo el cuerpo.
  - No repetir el tratamiento a los 7 días.
  - Usar corticoides potentes sin diagnóstico → enmascara lesiones (“sarna incógnita”).
  - No desinfectar ropa y sábanas.
  - Diagnosticar pediculosis sin observar liendres adheridas.
- 

## 8. Resumen final (5–7 ideas clave)



1. **Escabiosis** es causada por *Sarcoptes scabiei* y produce **prurito nocturno intenso** con surcos acarinos característicos.
2. **Permetrina 5% tópica** es el tratamiento de elección; **ivermectina oral** se usa en brotes o sarna costrosa.
3. Siempre tratar **a todos los contactos y desinfectar ropa y sábanas**.
4. **Pediculosis capitis** se manifiesta por prurito y liendres adheridas; se trata con **permetrina 1%**.
5. **Pediculosis pubis** se transmite sexualmente y puede afectar cejas o pestañas.
6. Las **recurrencias** son frecuentes si no se controlan las fuentes de reinfección.
7. En EUNACOM, el hallazgo clave es **familia con prurito nocturno + surcos interdigitales** → **diagnóstico: escabiosis**.